

이상지질혈증 환자를 위한 식이요법 가이드

포트폴리오 식단 연구에서는 LDL 콜레스테롤이 연구에 따라 약 13~29% 낮아졌습니다(평소 생활 속 연구 약 13%, 식사를 모두 제공한 연구 약 29%). 식이요법은 약을 먹더라도 함께 계속하는 기본 치료입니다. 핵심 식이 전략을 한눈에 정리했습니다.

한눈에 보는 핵심 수치

포화지방 상한

6

% 총열량 (~ 13g/일)

오메가-3 권장

2~3

회/주 (등푸른생선)

식이섬유 목표

25~40

g/일 (수용성 10~25g)

첫 지질검사

8~12

주 (식사 시작 후)

위험군별 LDL 목표

위험군	나의 상황	LDL 목표 (mg/dL)
초고위험군	관상동맥질환 — 스텐트 시술·심근경색을 겪은 경우 (치료 전보다 50% 이상 감소도 함께)	< 55
고위험군	의미 있게 좁아진 경동맥 플라크 · 동맥경화로 생긴 뇌경색·일과성 뇌허혈발작(TIA) — 정도·원인은 진료에서 확인	< 70
당뇨병	당뇨 10년 이상, 또는 다른 위험인자나 합병증이 하나라도 있는 경우	< 70
	그 외 당뇨 (10년 미만 · 위험인자·합병증 없음)	< 100
중등도 위험군	위험인자 2개 이상 (고혈압·흡연 등)	< 130
저위험군	주요 위험인자 1개 이하	< 160

중성지방은 위험군과 관계없이 150 미만을 목표로 합니다. 정확한 내 목표는 담당의와 확인하고, 자세한 설명은 'LDL 목표' 안내문(2쪽 아래 주소)을 참고하세요. — 한국지질·동맥경화학회 진료지침 제5판(2022)

피해야 할 지방 vs 권장 지방



줄일 지방 vs 늘릴 지방

피하세요 · 포화·트랜스지방	권장 · 오메가-3·불포화지방
삼겹살·갈비·가공육 — 포화지방과 나트륨이 함께 많습니다.	등푸른 생선 — 고등어·연어·정어리를 주 2~3회 선택합니다.
버터·생크림·치즈 — 빵·디저트 속 숨어 있는 포화지방입니다.	콩·두부·렌틸콩 — 동물성 단백질 일부를 식물성으로 바꿉니다.
마가린·쇼트닝·튀김 — 트랜스지방과 산화 지방 노출을 줄입니다.	귀리·보리·채소 — 수용성 식이섬유를 매 끼니에 더합니다.
라면·탄 음료·짠음주 — 중성지방 상승을 악화시킬 수 있습니다.	올리브유·견과류 — 하루 한 줌, 튀김 대신 무침·샐러드로 씁니다.

육류 지방·가공식품은 줄이고, 생선·콩·견과류·채소를 식탁의 중심으로 바꿉니다.

추적 관리

검사 주기: 식사 시작 후 8~12주에 첫 검사, 목표에 도달하면 6~12개월마다

목표 미달 시: 주치의와 스타틴·에제티미브 병용 상의

스타틴 복용 중: 자궁 주스·고용량 비타민 보충제와의 상호작용을 주치의와 확인하세요.

바로 연락: 근육통이 새로 생기면 ☎ 031-893-4560 · 가슴 통증·심한 호흡곤란은 119·응급실

광고바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 상태(스타틴 복용·간기능·신기능)에 따라 식이 처방이 달라질 수 있습니다. 다음 장에 포트폴리오 식단과 한·중·일 양식별 외식 가이드가 이어집니다.

포트폴리오 식단과 외식 시 식단 선택 가이드

연구에서 LDL을 약 13~29% 낮춘 4기동 식이전략과 한·중·일·양식별 권장·회피 메뉴, 일일 실천 루틴입니다.

🍷 포트폴리오 식단 4기동 — 네 가지 식품을 함께 먹습니다



기동 · 하루 양	주요 식품	실천 팁
1. 수용성 점성 식이섬유 하루 10~25g (최소 10g)	귀리(오트밀)·보리·콩·가지·오크라	아침 오트밀 1/2컵 또는 보리밥으로 시작
2. 식물성 스테롤·스타놀 하루 2g	강화 유제품(요거트)·식물성 오일·견과류(미량)	야채에 올리브유 1큰술 + 무염 견과류 간식
3. 식물성 단백질 하루 약 25~50g	두부·콩·렌틸콩·완두콩·에다마메	주 3회 이상 고기 반찬을 콩 단백질로 교체
4. 견과류 하루 30~45g (한 줌)	아몬드·호두·피스타치오·아마씨·치아씨드	무염·생견과 30g, 간식은 과자 대신 견과류

포트폴리오 식단 효과치는 임상시험 평균이며, 개인 반응 차이가 있습니다.

🍽️ 외식 메뉴 가이드 — 한식·중식·일식·양식

식문화	권장	피하기	한 줄 팁
한식	비빔밥(고추장 적게) · 생선구이 정식 · 찜밥	삼겹살·갈비 · 설렁탕·갈비탕 · 라면·부대찌개	국물 1/3만
중식	유산슬·볶음밥(소량) · 마파두부(소스 적게)	자장면·짬뽕 · 탕수육·깐풍기 · 군만두	기름·녹말 줄임
일식	생선·사시미 · 초밥(간장 살짝) · 된장국 소량	돈가스·튀김 · 라멘·돈코츠 · 마요 롤	간장은 짭기만
양식	올리브오일 스파게티 · 구운 연어 샐러드 · 발사믹	크림·로제 파스타 · 치즈 스테이크 · 햄·소시지	드레싱 별도

🚶 일일 실천 루틴

아침 — 오트밀 + 두유 + 견과류 한 줌
점심 — 잡곡밥 + 콩·두부 + 야채 반찬 2가지
저녁 — 등푸른 생선 또는 견과류 30g
운동 — 주 150분 걷기·자전거 (체중 5~10% 감량)
외식 — 메뉴 확인, 국물·드레싱 별도 요청

함께 보기 — 운동: edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/dyslipidemia-diet-exercise/ · 내 LDL 목표:

edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/ldl-target-by-risk/ · 중성지방 결과지: edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/high-triglycerides/

광고바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 한국지질·동맥경화학회 진료지침 제5판(2022) · 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 지침 · ESC/EAS · NCEP ATP III(2002) · 포트폴리오 식단 Jenkins JAMA 2003·2011 · 대한당뇨병학회 · 보건복지부 한국인 영양소 섭취기준

본 자료는 일반적 설명이며, 개인별 목표 수치와 식이·약물 조정은 검사 결과와 병력을 확인한 담당의가 결정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/dyslipidemia-diet/

